

Theo Dõi Đường Huyết - Hướng Dẫn Chi Tiết

Theo Dõi Đường Huyết - Hướng Dẫn Chi Tiết

TẠI SAO CẦN THEO DÕI ĐƯỜNG HUYẾT?

Đường huyết thay đổi liên tục theo bữa ăn, hoạt động thể lực và stress. Theo dõi giúp bạn hiểu cơ thể phản ứng như thế nào và điều chỉnh kịp thời.

CHỈ SỐ MỤC TIÊU (theo ADA 2024)

Đường huyết lúc đói (trước ăn sáng): 80–130 mg/dL

Đường huyết sau ăn 2 giờ: < 180 mg/dL

HbA1c (3 tháng): < 7% (tốt nhất < 6.5% nếu không bị hạ đường huyết)

KHI NÀO ĐO ĐƯỜNG HUYẾT?

Trước bữa ăn (đặc biệt bữa sáng): phản ánh đường huyết nền

Sau bữa ăn 1-2 giờ: xem thức ăn ảnh hưởng thế nào

Trước khi tập thể dục và sau khi tập

Khi cảm thấy chóng mặt, vã mồ hôi (nghi hạ đường huyết)

Trước khi đi ngủ (nếu đang dùng insulin)

HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (Hypoglycemia)

Đường huyết < 70 mg/dL là hạ đường huyết - CẦN XỬ TRÍ NGAY.

Triệu chứng: run tay, vã mồ hôi, tim đập nhanh, chóng mặt, đói cồn cào, mờ mắt.

XỬ TRÍ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT: Quy tắc 15-15

Uống ngay 15g đường: 3-4 viên kẹo glucose, hoặc 150ml nước cam, hoặc 1 thìa canh đường hoà nước.

Chờ 15 phút, đo lại.

Nếu vẫn < 70 mg/dL: lặp lại.

Sau khi đường huyết ổn: ăn nhẹ (bánh mì, chuối) để duy trì.

TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT (Hyperglycemia)

Đường huyết > 250 mg/dL: liên hệ bác sĩ.

Đường huyết > 300 mg/dL: nguy hiểm, cần cấp cứu.

Triệu chứng: khát nước nhiều, tiểu nhiều, mệt mỏi, đau bụng.

GHI NHẬT KÝ ĐƯỜNG HUYẾT

Ghi lại: ngày giờ, chỉ số, bữa ăn đã ăn, hoạt động, cảm giác.

Chia sẻ với bác sĩ mỗi lần tái khám để điều chỉnh thuốc.

XÉT NGHIỆM HbA1c

Đo trung bình đường huyết 2-3 tháng qua.

Làm 3-6 tháng/lần tại cơ sở y tế.

Mục tiêu < 7%: giảm nguy cơ biến chứng lên đến 37%.